

急性心肌梗死诊疗指南

一、定义与分型

急性心肌梗死（AMI）是指在冠状动脉病变的基础上，发生冠状动脉血供急剧减少或中断，使相应心肌严重而持久地急性缺血导致心肌坏死。根据心电图表现分为：

1. ST段抬高型心肌梗死（STEMI）：急性心肌缺血导致的胸痛，伴有持续性ST段抬高或新出现的左束支传导阻滞，以及心肌坏死生物标志物升高。
2. 非ST段抬高型心肌梗死（NSTEMI）：有急性心肌缺血的临床表现和心肌坏死标志物升高，但心电图无持续性ST段抬高。

二、临床表现

1. 典型症状：
 - 胸骨后或心前区剧烈压榨性疼痛，持续时间 ≥ 30 分钟
 - 疼痛可放射至左肩、左臂内侧、颈部、下颌或背部
 - 常伴有大汗淋漓、恶心呕吐、呼吸困难
 - 有濒死感和恐惧感
 - 含服硝酸甘油不能完全缓解
2. 不典型症状：
 - 老年患者可表现为突发呼吸困难、意识障碍
 - 糖尿病患者可无明显胸痛（无痛性心梗）
 - 部分患者以上腹痛、牙痛、咽部紧缩感为首发症状

三、诊断

诊断标准（满足以下三项中至少两项）：

1. 典型缺血性胸痛症状
2. 心电图动态演变：
 - STEMI：相邻两个或以上导联新出现ST段抬高
 - NSTEMI：ST段压低、T波倒置或一过性ST段抬高
3. 心肌坏死标志物升高：
 - 高敏肌钙蛋白I或T（hs-cTn）升高超过参考值上限第99百分位

- 肌酸激酶同工酶（CK-MB）升高

四、急诊处理流程

1. 院前急救：

- 立即拨打120急救电话
- 让患者平卧休息，避免活动
- 嚼服阿司匹林300mg（无禁忌证时）
- 舌下含服硝酸甘油0.5mg（收缩压>90mmHg时）
- 持续心电监护

2. 再灌注治疗策略：

STEMI患者再灌注治疗时间窗：

- 发病12小时内，首选直接经皮冠状动脉介入治疗（PCI）
- Door-to-Balloon时间目标：≤90分钟
- 无法在120分钟内完成PCI时，可考虑溶栓治疗
- 溶栓药物：阿替普酶、瑞替普酶或尿激酶
- Door-to-Needle时间目标：≤30分钟

3. 抗栓治疗：

- 双联抗血小板治疗（DAPT）：阿司匹林 + P2Y₁₂受体拮抗剂（替格瑞洛或氯吡格雷）
- 抗凝治疗：低分子肝素或普通肝素
- DAPT疗程：PCI术后至少12个月

五、住院期间管理

1. 监护：入院后持续心电监护至少48小时
2. 卧床休息：无并发症者12小时后可床上活动
3. 吸氧：血氧饱和度<90%时给予吸氧
4. 镇痛：吗啡3-5mg静脉注射（无禁忌证时）
5. 药物治疗：β受体阻滞剂、ACEI/ARB、他汀类药物
6. 评估左室功能：超声心动图评估LVEF

六、出院后管理

1. 长期药物治疗：阿司匹林（终身）、P2Y₁₂受体拮抗剂（12个月）、他汀类（终身）、 β 受体阻滞剂、ACEI/ARB
2. 心脏康复：出院后2-6周开始，每周3-5次运动训练
3. 危险因素控制：戒烟、控制血压血脂血糖、健康饮食、规律运动
4. 定期随访：出院后1个月、3个月、6个月、12个月及此后每年